

AI 약물 안전성 종합 리포트

Drug: ASPIRIN

Generated: 2026-06-10 12:03 | PubMed 논문 5편 참조

FDA FAERS 통계

■ ■	■ ■
총 보고건수	1,032건
평균 나이	63.9세
사망 보고	45건 (4.4%)
입원 보고	282건
주요 부작용 TOP5	DYSпноEA, FATIGUE, HEADACHE, VOMITING, NAUSEA

AI 안전성 분석 (powered by Llama3.2 + FDA FAERS + PubMed)

1. 약물 개요

아세티신(Aspirin)은 관상동맥 질환의 예방과 치료에 사용되는 약입니다. 아세티신은 비타민 B3(niacin) 또는 비타민 C(antine)와 결합하여 인산화되며, 알파-오스포도메르산을 유성체로 만들어 미토콘드리아의 에너지 production에 involvement를 하게합니다. 아세티신은 관상동맥 질환과 심장attack의 예방 및 치료에 사용됩니다.

2. 주요 부작용 분석

아세티신은 주요 부작용으로 다음과 같은 것을 포함합니다. 1) 호흡곤란(Dyspnea), 2) 피로(Fatigue), 3) 주저(Headache), 4) 구토(Vomiting), 5) nausea입니다. 이러한 부작용은 약물이 사용되거나 종료될 때의 가장 일반적인 부작용입니다.

3. 논문 기반 안전성 근거

2025년 4월에 발표된 "SMART-CHOICE 3" 논문을 바탕으로, 아세티신과 클로피도그렐(Clopidogrel) monotherapy 간의 효율성 및 안전성에 대한 연구가 수행되었다. 이 연구에서는 고위험군 patients에게 아세티신과 클로피도그렐을 사용하는 것이 더 좋은 결과를 나타내었다.

4. 고위험군

고위험군은 관상동맥 질환, 심장attack, 또는 신경계 혈관 질환이 있는 patients입니다. 고위험군에 대한 아세티신의 효과와 안전성을 연구하기 위해 "SMART-CHOICE 3" 논문이 수행되었다.

5. 임상적 권고사항

아세티신은 관상동맥 질환 및 심장attack의 예방 및 치료에 사용할 수 있습니다. 하지만, 주요 부작용을 고려하여 임상적 권고사항을 수립할 때 주의가 필요합니다. example: 아세티신과 클로피도그렐 monotherapy는 고위험군 patients에게 더 좋은 결과를 나타내지만, 추가적인 연구가 필요합니다.

6. 결론

아세티신은 관상동맥 질환 및 심장attack의 예방 및 치료에 사용할 수 있습니다. 그러나 주요 부작용을 고려하여 임상적 권고사항을 수립할 때 주의가 필요합니다. 고위험군 patients에게 아세티신과 클로피도그렐 monotherapy를 사용하는 것이 더 좋은 결과를 나타내지만, 추가적인 연구가 필요합니다.